

Mujer de 44 años con reglas muy abundantes y cansancio

Caso clínico de Ginecología · Nivel: estudiante de grado · Código: GIN-03

Cómo usar este documento: la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

Datos de filiación

Nombre	Cristina B. F.
Edad	44 años
Profesión	Comercial
Estado civil	Casada
Fórmula obstétrica	G2 P2 A0
Edad gestacional	No gestante

Motivo de consulta

Reglas cada vez más abundantes y largas, con coágulos, y mucho cansancio.

Antecedentes

Personales	Sin enfermedades crónicas conocidas.
Familiares	Sin interés.
Gineco-obstétricos	Dos partos. Ciclos previamente regulares. Desde hace 1 año reglas más abundantes (hipermenorrea) y duraderas. No anticoncepción hormonal.
Hábitos	No tabaco.

Historia de la enfermedad actual

Sangrado menstrual abundante de 7-8 días con coágulos, que le obliga a cambiar compresa/tampón cada 1-2 horas y le mancha la ropa. Sensación de presión/peso en hipogastrio y aumento de la frecuencia urinaria. Cansancio, palidez, disnea de esfuerzo y mareo (anemia). No sangrado entre reglas ni poscoital. No pérdida de peso ni fiebre.

Exploración física

TA 112/70 mmHg, FC 96 lpm. Palidez de piel y mucosas. Abdomen: útero aumentado de tamaño palpable, irregular, no doloroso. Especuloscopia: cérvix sano, sin lesiones, sangrado procedente de cavidad. Tacto bimanual: útero aumentado y de superficie irregular (nodular).

Pruebas complementarias disponibles

- Test de embarazo: negativo.
- Hemograma: Hb 9,2 g/dL, microcitosis e hipocromía (anemia ferropénica). Ferritina baja.
- Ecografía transvaginal: útero aumentado con varios miomas, el mayor intramural de 5 cm que deforma la cavidad; endometrio de grosor normal.
- Coagulación normal. TSH normal.

- Citología cervical reciente normal. Biopsia endometrial valorada por edad/factores de riesgo: sin atipias.

Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Cristina, 44 años. Tus reglas se han vuelto muy abundantes y largas, con coágulos, y estás agotada, pálida y te falta el aire al subir escaleras. Hablas con normalidad. Cuentas, si preguntan, que notas presión en el bajo vientre y que orinas más a menudo. Aclaras que no sangras entre reglas ni después de las relaciones. Estás preocupada por el cansancio.

PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

Diagnóstico principal

Sangrado uterino anormal (hipermenorrea) por miomatosis uterina, con anemia ferropénica secundaria. Útero aumentado e irregular con miomas en ecografía.

Diagnóstico diferencial

- Hiperplasia/pólipo endometrial
- Adenomiosis
- Trastorno de la coagulación
- Disfunción tiroidea
- Carcinoma de endometrio (descartar por edad)
- Sangrado uterino disfuncional/anovulatorio de la perimenopausia

Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Cuantificar el sangrado (cambios de compresa, coágulos, duración) y el impacto (anemia).
- Síntomas de masa: presión pélvica, síntomas urinarios.
- Diferenciar de sangrado intermenstrual/poscoital (orientaría a patología cervical/endometrial).
- Descartar embarazo y valorar riesgo de patología endometrial por la edad.

Pruebas que debería solicitar

- Test de embarazo.
- Hemograma + ferritina (anemia ferropénica), coagulación, TSH.
- Ecografía transvaginal (miomas, grosor endometrial).
- Citología cervical y biopsia endometrial para excluir hiperplasia/carcinoma según edad y factores de riesgo.

Manejo / tratamiento correcto

Corregir la anemia (hierro oral/IV). Tratamiento del sangrado: opciones médicas (antifibrinolíticos como ácido tranexámico, AINE, anticonceptivos combinados o DIU de levonorgestrel; análogos de GnRH para reducir tamaño prequirúrgico). Tratamiento de los miomas según síntomas y deseo genésico: miomectomía, embolización de arterias uterinas o histerectomía si síntomas importantes y paridad cumplida. Individualizar.

Rúbrica de evaluación

Criterio evaluado	Puntos
Cuantifica el sangrado y detecta la anemia (clínica + hemograma + ferritina)	20
Distingue hipermenorrea de sangrado intermenstrual/poscoital	10
Descarta embarazo y valora patología endometrial según edad	15
Solicita ecografía transvaginal e identifica los miomas	20
Diagnostica sangrado uterino anormal por miomas con anemia	15
Plan: corregir anemia + tratamiento médico/quirúrgico individualizado	20
TOTAL	100

Errores frecuentes / banderas rojas

- No tratar la anemia.
- No descartar carcinoma de endometrio en mujer de 44 años con sangrado anormal.
- Indicar histerectomía sin agotar opciones médicas/conservadoras ni valorar deseo genésico.
- Olvidar el test de embarazo.